Persona

Avaliação do pé diabético no PEC e-SUS APS · Etapa de Definição

Persona primária · usuária-chave

Camila Andrade



IDADE
29 anos

PROFISSÃO
Enfermeira da Estratégia Saúde da Família

EDUCAÇÃO
Graduação em Enfermagem; especialização em Saúde da Família em andamento

ONDE TRABALHA
UBS de pequeno porte, uma equipe de ESF, área com parte rural

EXPERIÊNCIA
2 anos na APS; usa o PEC todos os dias

PERSONALIDADE

Cuidadosa e prática. Se preocupa com o paciente além da consulta e faz visita domiciliar quando o ACS avisa. Quando falta material, improvisa para não deixar de avaliar. Quer fazer o exame do jeito certo, não só cumprir o indicador.

> *Quais dos meus diabéticos estão sem avaliação dos pés este ano? E quem tem o pé de risco?*
>
> *Eu preciso fazer a classificação, não só marcar qualquer coisa no PEC.*
>
> *Não pode ser muito grande. A gente não tem muito tempo na unidade.*

CONTEXTO

É ela quem faz o exame dos pés na UBS e aciona o médico quando o caso já está grave. A consulta de diabetes é cheia: pressão, glicemia, hemoglobina glicada, alimentação e, por último, os pés. A UBS não tem monofilamento nem diapasão. Preenche a ficha de papel, que vai para a pasta dos diabéticos, e depois escreve a mesma avaliação no PEC, em texto livre, e lança o código do exame do pé.

DESEJOS, NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

- Fazer uma avaliação completa e padronizada, mesmo sem monofilamento e diapasão.
- Registrar uma vez só, direto no PEC.
- Saber o risco de cada paciente e quando ele deve voltar.
- Ver quem está atrasado ou com risco alto sem depender só do ACS.
- Evitar amputações que poderiam ser prevenidas.

DORES E FRUSTRAÇÕES

- Improvisa o teste de sensibilidade (com fio dental) por falta de instrumento.
- Anota tudo duas vezes: no papel e no PEC, em texto livre de 250 caracteres por perna.
- Para ver a avaliação anterior, abre o prontuário consulta por consulta.
- O PEC mostra se o código foi lançado, mas não mostra o risco.
- Já viu um pé grave chegar tarde demais e terminar em amputação.

FATORES IMPORTANTES

Domina o PEC e aceita uma ferramenta nova se ela for curta e couber na consulta. Confia numa classificação automática quando ela coincide com o seu julgamento clínico: quer decidir, não só clicar. O registro dela pontua na boa prática F do indicador C4.

Como a persona foi construída

Para a revisão do grupo na reunião de quinta (12/11)

Responsável: Jennifer

Passo a passo do livro (seção 4.1.3a e seção 6.3)

1. **Partir do que a imersão levantou.** Relemos o relatório e a transcrição da entrevista, o benchmarking e a Matriz CSD 2ª versão. A persona não traz informação nova; ela sintetiza essas fontes.
2. **Decidir quem é a persona primária.** No livro, a equipe discutiu se fazia uma persona de médico e outra de enfermeiro e escolheu a enfermeira, porque é a enfermagem que mais faz aquele trabalho. Aqui a decisão é a mesma: a entrevista mostra que *"geralmente só a enfermeira faz"* o exame, e o médico entra nos casos agravados.
3. **Preencher o template** (Bridge/UFSC, fig. 4.6): nome, idade, profissão, educação, personalidade, citação, contexto, desejos e motivações, dores e frustrações, fatores importantes.
4. **Validar com o grupo** na reunião de quinta, antes do mapa de empatia (Karen) e do MoSCoW.
5. **Usar como referência:** diante de uma dúvida de projeto, perguntar *"a Camila conseguiria preencher isso numa consulta de diabetes?"*.

De onde veio cada elemento

Elemento da persona	Evidência	Fonte
Enfermeira da ESF, 2 anos de APS	Entrevistada formada há 2 anos, 1 ano na APS	Entrevista, pergunta 1
UBS pequena com área rural, sem monofilamento e diapasão	UBS rural; só tinha a ficha de papel e fio dental	Entrevista, P1 e P4; CSD (certeza)
É ela quem faz o exame; aciona o médico nos casos graves	"Geralmente só a enfermeira faz"	Entrevista, P3
Consulta cheia, pouco tempo	PA, CA, glicemia, HbA1c, alimentação; "não temos muito tempo"	Entrevista, P5 e P14; CSD (suposição)
Registro duplo, texto livre de 250 caracteres	Ficha em pastas por grupo, mais texto corrido no PEC	Entrevista, P6 e P7; benchmarking 3.1
Abre prontuário consulta por consulta	Filtro mostra só o código, não os achados	Entrevista, P8 e P10; benchmarking 3.1
Depende do ACS para achar quem está atrasado	"Não dependeríamos só da visita mensal do ACS"	Entrevista, P10 e P12
Quer classificar, não só clicar	Confiaria se o risco coincidisse com o dela	Entrevista, P13; CSD (suposição)
Quer formulário curto dentro do PEC	"Simples e pequeno, mas que permita avaliação adequada"	Entrevista, P12 e P14
Já viu caso terminar em amputação	Caso relatado de necrose → vascular → amputação → óbito	Entrevista, P11
Registro conta para a boa prática F	Enfermeiro está no Quadro 07 da nota do C4	Nota Metodológica C4; CSD (certeza)

Pontos para o grupo decidir na quinta

- **Usuários secundários:** o médico (casos graves) e o ACS (busca ativa) aparecem na jornada, mas não ganham persona própria nesta etapa, como no exemplo do livro. Se o grupo quiser, viram protopersonas depois.
- **Limite da amostra:** a persona se apoia numa única entrevista, de UBS rural. A Matriz CSD mantém como dúvida se a realidade se repete em UBS urbanas. A persona deve ser revista se surgirem novos dados.
- **Detalhes fictícios** (nome, idade exata, especialização) servem para dar rosto à persona e podem ser trocados pelo grupo.

> A persona é a base para a próxima ferramenta: a jornada do usuário (também da Jennifer) segue a Camila numa consulta de diabetes, do momento em que ela chama o paciente até o registro no PEC e o retorno.